

"33_Impact de l’obésité sur le profil cardiométabolique des patients atteints de diabète de type 2"

I. LAIDOUNI, N. KHODJA, B. BENCHAIB

Introduction

L’obésité constitue un facteur majeur de la physiopathologie du diabète de type 2 (DT2) et un déterminant important du risque cardiométabolique. En favorisant l’insulinorésistance, la dyslipidémie athérogène et les complications cardiovasculaires, elle contribue à l’aggravation du pronostic des patients diabétiques. L’objectif de cette est d’évaluer l’impact de l’obésité sur le profil cardiométabolique des patients atteints de DT2.

Patients et méthodes

Une étude transversale analytique a été menée durant six mois chez 88 patients atteints de DT2 afin d’évaluer l’association entre l’obésité et les principales anomalies cardiométaboliques. Les paramètres étudiés comprenaient l’indice de masse corporelle (IMC), la glycémie à jeun, l’HbA1c, l’acide urique ainsi que le profil lipidique (cholestérol total, triglycérides, HDL-C et LDL-C). Les analyses statistiques ont été réalisées avec IBM SPSS version 26 avec un seuil de significativité $p < 0,05$.

Résultats

L’âge moyen était de $60,13 \pm 9,95$ ans, et un sex-ratio de 1,53. L’IMC moyen est de $27,41 \pm 4,74$ Kg/m² avec une différence significative entre les deux sexes ($29,36 \pm 5,06$ Kg/m² chez les femmes vs $25,93 \pm 3,94$ Kg/m² ; $p < 0,05$) L’obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) était significativement plus élevée chez les femmes (35,5% chez les femmes vs 14,6% des hommes) (Figure1). L’HbA1c moyenne était de $8,56 \pm 1,80$ % (Tableau .I). Les principales anomalies cardiométaboliques étaient un LDL-C élevé (42,04 %), un HDL-C bas (39,77 %), une hyper uricémie (37,50 %), une hypercholestérolémie (25 %) et une hypertriglycéridémie (18,18 %).

L’hypertension artérielle concernait 53 % des patients et les complications cardiovasculaires 29% (Figure 2.)

Tableau I . Paramètres biochimiques des patients

Paramètres	Patients (n=72)	Femmes (n=31)	Hommes (n=41)	P
Glycémie (g/L)	1,52 ± 0,49	1,57 ± 0,53	1,49 ± 0,45	0,491
HbA1C (%)	7,17 ± 1,43	7,44 ± 1,58	6,98 ± 1,29	0,190
Urée (g/L)	0,36 ± 0,16	0,34 ± 0,13	0,38 ± 0,19	0,286
Créatinine (mg/L)	10,25 ± 2,99	9,67 ± 2,34	10,69 ± 3,36	0,134
Acide Urrique (mg/L)	58,85 ± 18,25	56,87 ± 19,10	60,34 ± 17,66	0,433
Cholestérol total (g/L)	1,52 ± 0,41	1,55 ± 0,41	1,51 ± 0,41	0,710
Cholestérol - HDL (g/L)	0,45 ± 0,11	0,49 ± 0,12	0,42 ± 0,09	0,016*
Triglycérides TG (g/L)	1,29 ± 0,70	1,22 ± 0,49	1,39 ± 0,83	0,479
Cholestérol -LDL (g/L)	0,59 ± 0,47	0,81 ± 0,33	0,82 ± 0,35	0,952
ApoB (g/L)	0,92 ± 0,28	0,92 ± 0,28	0,92 ± 0,29	0,988
TGO (UI/L)	18,06 ± 11,17	15,45 ± 5,74	20,02 ± 13,65	0,06
TGP (UI/L)	16,39 ±13,72	13,68 ± 11,20	18,41 ±15,17	0,130

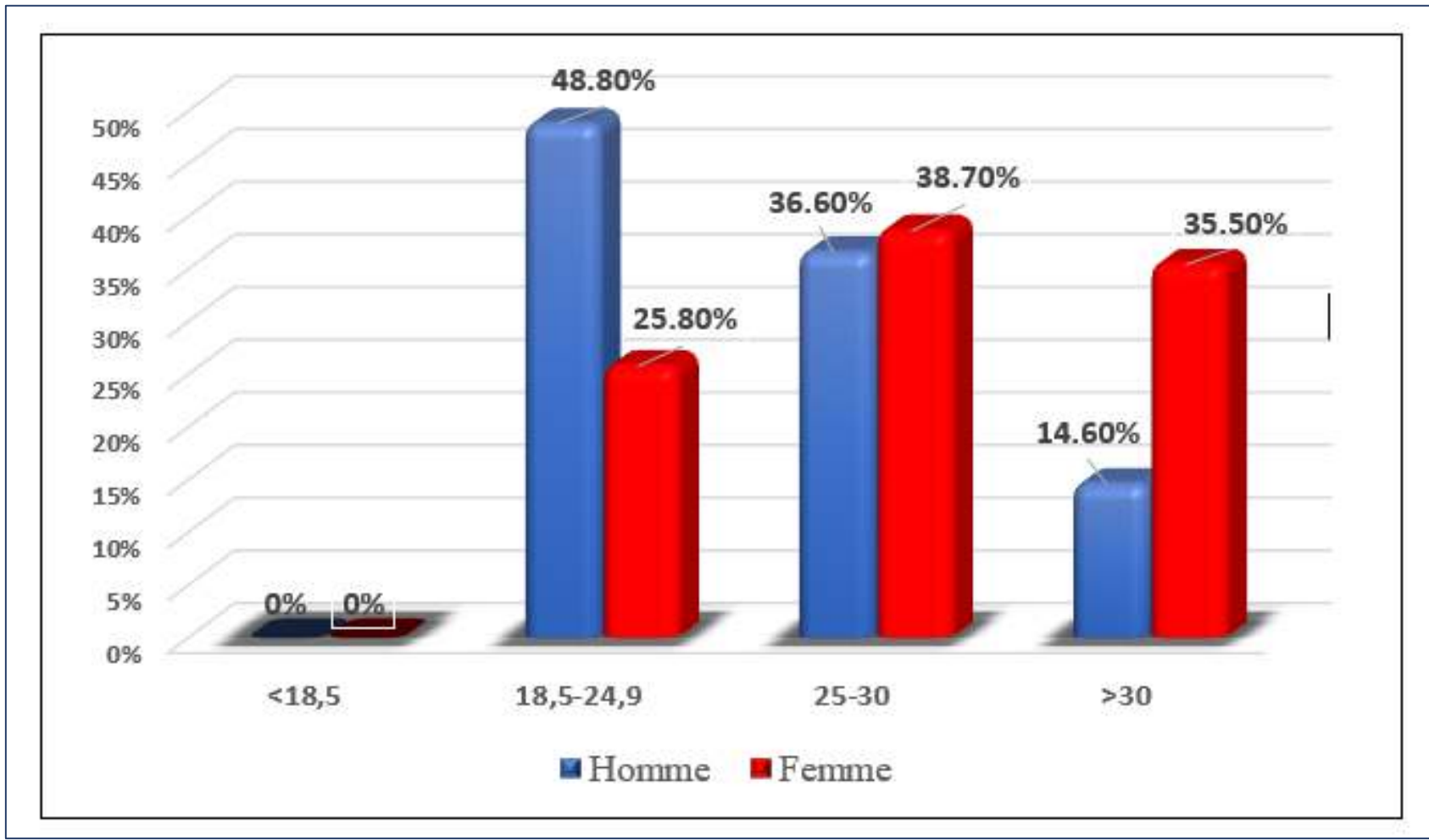


Figure 1. Répartition des patients selon l'IMC et par sexe.

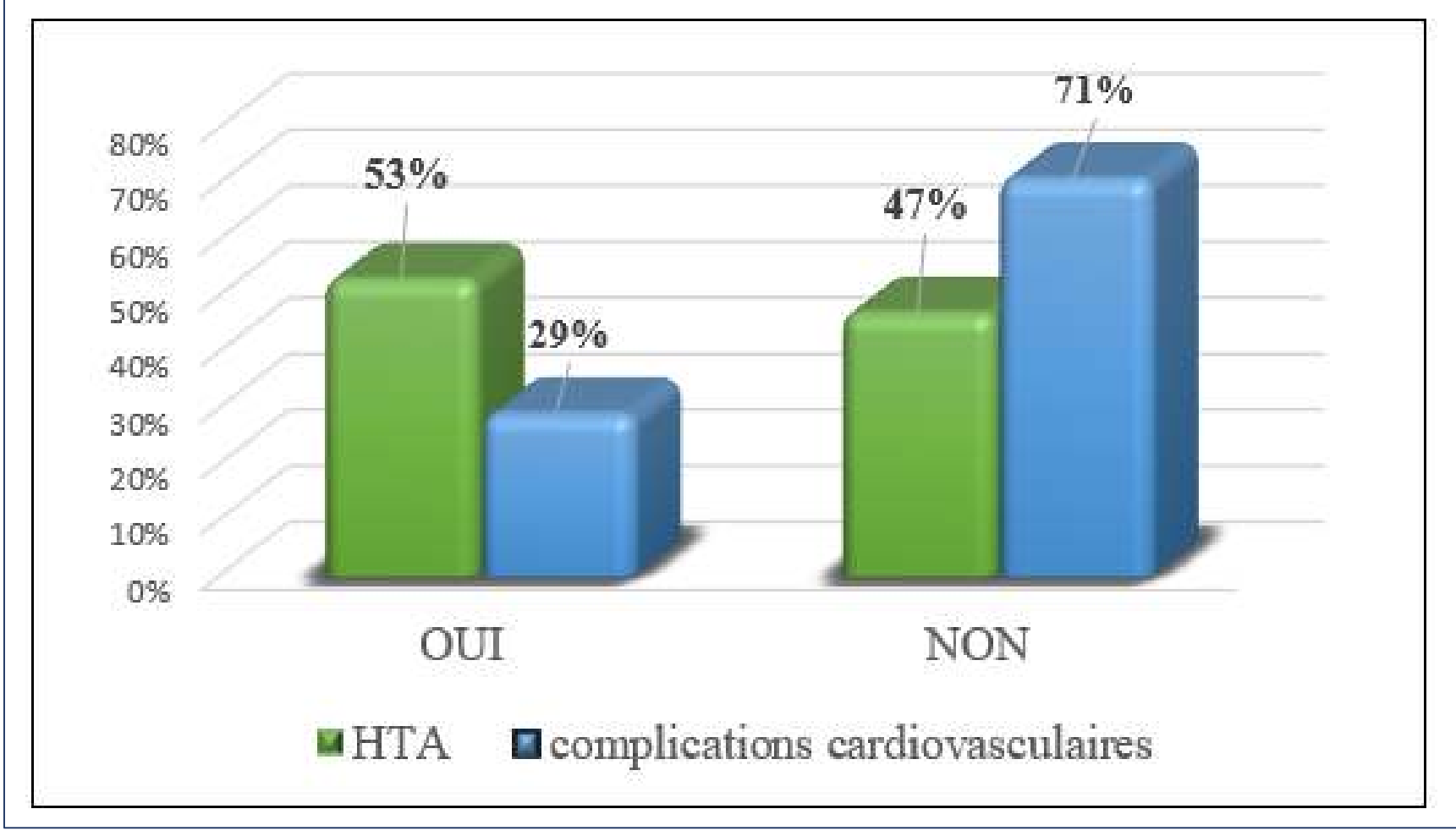


Figure 2 . Répartition des patients selon les complications.

Il existe une corrélation significative positive entre la glycémie, l’HbA1c et l’IMC (respectivement $r = 0,668$, $r = 0,402$ $p<0,05$). Il existe également une corrélation significative positive entre le cholestérol - LDL et le cholestérol total ($r= 0,909$, $p<0,05$). De même qu’une corrélation significative positive entre l’HbA1C, l’IMC et l’ancienneté du diabète (respectivement : $r = 0,445$; $r = 0,233$, $p <0,05$).

Par ailleurs il existe une corrélation significative négative entre les triglycérides et le cholestérol–HDL ($r = - 0,326$, $p<0,005$) ainsi qu’une corrélation significative négative entre le cholestérol–HDL et l’HbA1C($r= -0,238$, $p <0,05$).

Discussion

L’âge moyen de notre population était de $60,13 \pm 9,95$ ans, ce qui confirme le caractère tardif du diagnostic du DT2, souvent établi après 50 ans. Par ailleurs l’indice de masse corporelle (IMC) moyen était de $27,41 \pm 4,74$ kg/m², et une différence hautement significative a été observée entre les sexes, avec un IMC moyen de $29,36 \pm 5,06$ kg/m² chez les femmes contre $25,93 \pm 3,94$ kg/m² chez les hommes ($p < 0,05$). Cette obésité féminine, revêt une importance particulière dans le cadre du DT2, car elle favorise non seulement la résistance à l’insuline, mais également une dyslipidémie pro-athérogène caractérisée par une élévation des lipoprotéines telles que les VLDL et LDL

Notre étude a mis en évidence plusieurs corrélations significatives entre les paramètres biologiques mettant en lumière les interactions entre déséquilibre glycémique, anomalies lipidiques et surcharge pondérale dans le diabète de type 2.

Conclusion

L’obésité est fortement associée à une altération du profil cardiométabolique chez les patients atteints de DT2. Ces résultats soulignent l’importance d’une prise en charge précoce intégrant le contrôle pondéral afin de réduire le risque cardiométabolique et de prévenir les complications cardiovasculaires.

Références Bibliographiques

Rawshani A, et al. Risk factors, mortality, and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2024;390(1):31–44.

Berndsen ZT, Cassidy CK. The structure of apolipoprotein B100 from human low-density lipoprotein. Nature. févr 2025;638(8051):836-43.

Taskinen MR, Borén J. New insights into the pathophysiology of dyslipidemia in type 2 diabetes. Atherosclerosis. 2015;239(2):483–95